

3 钙离子拮抗剂

目前临床上常用于治疗门脉高压症的有以下几种药物:

3.1 维拉帕米: Kong 等^[8]对 10 例 HBsAg 阳性的肝硬化病人用维拉帕米 10mg 静注, 1h 后肝静脉楔压和游离肝静脉压间差值降低 14%, 继予 2mg/kg/d 口服 1mo、3mo 后, 肝静脉压力梯度持续降低 ($P < 0.01$)。李定国等^[9]对 30 例肝硬化食道静脉曲张患者予 120mg/d 口服, 1wk 后食道静脉压力开始明显下降, 1mo 后平均下降 23%, 明显优于心得安的对照组 ($P < 0.01$)。

3.2 硝苯吡啶: 李定国等^[9]对 30 例肝硬化食道静脉曲张患者给予硝苯吡啶 60mg/d 口服, 1mo 后测定食道静脉压力下降 25%, 明显优于心得安组的 9.3% ($P < 0.01$)。对 11 例患者给予舌下含服 20mg, 25min 后测定门脉压下降 32.7%。另对有食道静脉曲张破裂出血史的 31 例患者服药后随访 1.5 年, 再出血者仅 8 例 (25.8%), 明显少于心得安组 42 例再出血 19 例 (45.2%)。说明硝苯吡啶能持续地降低门脉压, 对预防食道静脉曲张破裂出血疗效良好。

3.3 汉防己甲素: 狄剑时等^[10]报道, 用汉防己甲素 50mg, 3 次/d, 治疗门脉高压症 30 例, 服药 1wk, 1mo 及 3mo 后, 门静脉、脾静脉和肠系膜静脉血流量下降, 食道曲张静脉压及门脉压下降, 其下降程度均明显优于心得安对照组 ($P < 0.05$)。李定国等^[9]临床应用表明, 本药在钙离子拮抗剂中降门脉压作用最为显

著。他们治疗肝硬化门脉高压症 30 例, 150mg/d, 1mo 后测量食道曲张静脉压力下降 32%, 明显优于心得安组。另外, 他们对 33 例肝硬化食道静脉曲张破裂出血患者治疗 1 年半, 再出血者仅 4 例 (12.12%), 明显优于同类的其它药物 ($P < 0.05$), 是目前预防食道静脉曲张破裂出血效果最好的药物。

参考文献

- 1 Kroeger RJ, Groszmann RJ. The effect of the combination of nitroglycerin and propranolol on splanchnic and systemic hemodynamics in a portal hypertensive rat model. *Hepatology*, 1985, 5: 425
- 2 Garcia-Tsao G, Groszmann RJ. Portal hemodynamics during nitroglycerin administration in cirrhotic patients. *Hepatology*, 1987, 7: 805
- 3 Bosch J. Effect of pharmacological agents on portal hypertension: a haemodynamic appraisal. *Clin Gastroenterology*, 1985, 14 (1): 169
- 4 杨大国, 李绍白, 林宝英, 等. 门静脉血管调节机制对肝脏血液动力学影响的实验研究. *中华实验外科杂志*, 1986, 3 (4): 173
- 5 Mills PR, Rae AP, Farah DA, et al. Comparison of three adrenergic blocking agent in patients with cirrhosis and portal hypertension. *Gut*, 1984, 25 (1): 73
- 6 魏镜龙, 赵秋, 李绍白. 酚妥拉明治疗肝硬化食道胃底静脉曲张出血的研究. *中华内科杂志*, 1989, 28 (9): 532
- 7 但自力, 赵秋, 李绍白. 垂体后叶素和酚妥拉明分别及联合应用对肝脏和全身血液动力学影响的实验研究. *中华医学杂志*, 1990, 70 (7): 367
- 8 Kong CW, Lay CS, Tsai YT, et al. The hemodynamic effect of verapamil on portal hypertension in patients with postnecrotic cirrhosis. *Hepatology*, 1986, 6: 423
- 9 李定国, 陆汉明, 李宜海, 等. 钙通道阻滞剂在肝硬化门脉高压患者中的应用. *中华医学杂志*, 1990, 70 (7): 370
- 10 狄剑时, 权启镇, 李心民, 等. 钙通道阻滞剂对肝硬化门脉系血流动力学及食道曲张静脉压力影响的研究. *临床肝胆病杂志*, 1990, 6 (2): 70

(1992 年 1 月 1 日收稿)

氟喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用

俞荣森 (浙江丽水地区医院临床药理室 323000)

氟喹诺酮类药物开发以来, 由于具有广谱和较强的抗菌作用, 受到临床欢迎。本类药物的不良反应及与其它药物的相互作用也引起医药界的注意, 研究报道较多。现以国内常用的氟喹诺酮类为主介绍如下:

氟喹诺酮类的不良反应

1 消化系统

有恶心呕吐、食欲不振、腹痛、腹泻等, 一般不严重。不良反应的发生率低于萘啶酸和吡哌酸。个别报道有仅口服 0.4g 氟哌酸, 2h 后即发生腹痛、腹泻。

2 神经系统

副作用有眩晕、嗜睡、头痛、步态不稳,发生率为1%左右,手指震颤、手足麻木、精神不安亦有所见。视力和知觉改变较少发生。研究认为,氟喹诺酮类可通过抑制 γ -氨基丁酸(GABA)受体激动剂毒蝇醇与GABA的结合,使中枢神经兴奋性增高,发生癫痫等症状。有报道氟喹诺酮类药 Acrosoxacin 100~400mg 治疗淋病中,神经系统副作用发生率高达33~58%^[1]。国内有过口服氟哌酸引起周围神经炎的报道,患者服药后四肢麻木烧灼感、针刺样疼痛。^[2]

3 变态反应

发生率较低,症状为皮疹、荨麻疹、红斑或皮肤发红、发热、瘙痒、眼睑及球结膜充血。尚有光敏反应,女性发生较多,建议使用氟喹诺酮类药物后避免长期日晒^[1]。甲氟哌酸、氟嗪酸的光敏反应有时表现为松甲、脱甲,可用冷敷和皮质激素治疗^[4]。

变态反应有时可十分严重,1987~1988年美FDA收到环丙氟哌酸不良反应报告262例,其中过敏或类过敏反应15例,给药5min至1h内出现反应,有低血压、休克、哮喘、呼吸困难、呼吸暂停、喉头水肿、喉痉挛等^[3]。血管神经性水肿、高血压、过敏性脉管炎等也有发生^[4]。部分病人危及生命。

日本和美国统计消化系统、中枢神经系统的副作用及过敏发生率见下表^[1,5]:

附表 氟喹诺酮类主要不良反应发生率

药 品	被评价 例数(人)	消化系 统(%)	中枢神 经(%)	过敏 反应
氟哌酸	(日) 2062	2.9	0.9	0.3
	(美) 1540	1.8	1.4	0.6
氟嗪酸	(日) 2856	3.2	0.6	0.7
	(美) 4785	3.2	0.9	0.7
氟啶酸	(日) 2516	3.8	1.2	0.7
	(美) 2530	3.8	1.2	0.2
环丙氟 哌 酸	(日) 2575	2.1	0.4	0.4
	(美) 1690	5.0	1.6	1.4

4 心血管系统

心悸、胸部压迫感可以出现,停药一般可以消失。严重的病例1989年和1990年马晓文报道^[6,7],一例口服氟哌酸0.4g2h后发生心房

颤动,病人原无心脏病,认为与个体差异有关;另一例服氟哌酸常规量,出现心慌、胸闷、头晕,心电图检查示阵发性室上速,发作时间与血药浓度峰时一致,系氟哌酸引起的预激综合征。

5 血象改变

日本统计^[5]氟喹诺酮类引起嗜酸性细胞增多发生率0.5~2.2%,白细胞减少发生率0.1~0.7%,血小板减少发生率0.1~0.2%,可有出血发生。国内报道口服氟哌酸引起急性溶血性贫血二例^[9]。

1989年Pace J L报道一例使用氟嗪酸200mg Bid×5d,发生出血性水泡样和紫癜样药疹,24h后大量黑便,伴血尿,胃部明显出血。胃镜示幽门前溃疡出血、小结状出血,数天后死于第二次大出血。尸检见纵膈、心包、胃肠道、肾锥体、膀胱广泛出血,十二指肠穿入胰腺^[8]。发生机理不甚清楚,似与凝血功能有关。

6 肝肾损害

一般不严重,主要有GOT、GPT、AL-P和LDH升高。日本统计^[5]发生率为1~4%,环丙氟哌酸>氟哌酸>氟嗪酸>氟啶酸。肾损害表现为尿素氮和血清肌酐上升,发生率为0.1~0.5%,氟嗪酸>氟啶酸>环丙氟哌酸>氟哌酸,尿蛋白出现率0.07~0.2%。少数患者可出现病理改变,肾小管损伤伴间质水肿及细胞浸润,出现嗜酸细胞和尿中嗜酸性细胞增多症及结晶所致的血尿。继发性肾衰多数发生于65岁以上老人^[4]。

7 软骨及骨损害

临床中有报道服用环丙氟哌酸后引起关节痛、关节病等,一般认为儿童和青少年不宜使用^[1,10]。

药物相互作用

1 影响氟喹诺酮类吸收^[11,12]

含铝镁的抗酸剂与环丙氟哌酸同时服用,可使后者血药活性几乎全部消失,碳酸钙可中等程度降低环丙氟哌酸和氟哌酸的吸收,硫糖铝降低后者吸收作用则很强。氟啶酸、氟嗪酸

与氢氟化铝合用,峰浓度降低,峰时延迟,AUC减少,故认为氟喹诺酮类与铝、镁、锌、铜、铁、钙等多价阳离子产生螯合作用,影响吸收,应避免合用。

磷酸盐结合剂可以降低血清和透析液中环丙氟哌酸浓度76%和92%,透析病人应避免使用含磷酸盐的透析液,改用其它透析液。

胃复安加速胃排空,可使环丙氟哌酸早进入肠道而增加吸收。甲氧咪呱可使环丙氟哌酸的血药浓度升高,可能也与吸收有关。

2 影响氟喹诺酮类的清除^[12]

丙磺舒可通过降低肾清除率使后者血药浓度升高。

3 影响氟喹诺酮类的毒副作用^[1,11,12]

日本报道7例氟啶酸与联苯丁酮酸合用发生惊厥,认为与中枢神经中GABA与受体结合被喹诺酮类抑制有关。实验证明,除阿司匹林外,其它非类固醇消炎镇痛药可促使喹诺酮类诱发惊厥、癫痫,急性脑血管障碍患者应避免使用本类药品。惊厥是可逆的,中止给药,给予巴比妥类可以解救。

4 氟喹诺酮类对其它药物的影响^[1,4,11,12]

氟喹诺酮类可抑制肝微粒体细胞色素P450同功酶,引起甲基黄嘌呤类代谢减慢,使茶碱血药浓度升高而中毒,老年人尤易发生。氟啶酸、环丙氟哌酸、甲氧哌酸与茶碱合用,茶碱血药峰浓度可分别增高111%,23%、20%,氟哌酸与氟啶酸的影响较小,无临床意义。老

年人合用环丙氟哌酸与茶碱,茶碱的血药浓度可增加2~3倍,曾有因此中毒致死的报道。

对华法令也有相似的作用,氟啶酸、氟哌酸与华法令合用可使抗凝过度,凝血酶原时间延长而出血。氟啶酸无此作用,但它仍是肝酶抑制剂,应谨慎使用。与环孢霉素合用,可以引起急性肾功不全。但研究认为两者合用对药代动力学无影响,若需合用应注意肾功监测。氟哌酸、氟啶酸与卡氮芥合用可使后者对DNA损害加重,细胞毒性增大。

参考文献

- 1 Stahlmann R. 喹诺酮类的安全性. 国外医药抗生素分册, 1991, 12 (6) : 450~456
- 2 林云高. 诺氟沙星引起周围神经炎1例. 新药与临床, 1990, 9 (3) : 171
- 3 Davis H et al. 环丙氟哌酸治疗后的类过敏反应. 国外医药抗生素分册, 1991, 12 (3) : 239
- 4 Paton J H et al. 喹诺酮类不良反应的临床表现及处理. 国外医学药学分册, 1991, 18 (6) : 357~359
- 5 重野秀明, 斋藤厚. ニューキノロン感染症副作用. 诊断七治疗, 1986, 74 (7) : 1397
- 6 马晓文. 氟哌酸引起心房颤动一例. 中华内科杂志, 1989, 28 (7) : 437/
- 7 马晓文. 诺氟沙星诱发预激综合征1例. 新药与临床, 1990, 9 (4) : 221
- 8 Pace J L et al. 与氟啶酸有关的致命性血管炎. 国外医药抗生素分册, 1991, 12 (3) : 238
- 9 尚建中. 诺氟沙星致急性溶血性贫血二例. 新药与临床, 1990, 9 (4) : 221
- 10 Maggiolo F. 喹诺酮类在儿童使用利弊. 国外医药抗生素分册, 1991, 12 (3) : 223
- 11 北村正崎. 吡啶酮酸类抗菌药与其它药物相互作用. 国外医药抗生素分册, 1991, 12 (1) : 68~69
- 12 Polk R K. 氟喹诺酮类抗菌药与其它药物的交互作用. 国外医药抗生素分册, 1991, 12 (3) : 236~237

(1992年2月17日收稿)

脚踏吸引器抽滤检查不溶性微粒

王志高 (空军襄樊医院 441003)

我院采用脚踏吸引器抽气减压方法使滤膜抽滤近干,然后置显微镜下检查不溶性微粒。此法操作易于进行,同时也克服了反复抽气以及真空泵法稍一疏忽所致的负压过大、使滤膜受损的缺点。笔者认为此法简单、易行、实用。

具体方法介绍如下:

1 将橡胶管的一端套在抽滤瓶的侧口处,另一端接脚踏吸引器。

2 把带橡胶塞的滤器冲洗至洁净,安装在抽滤瓶口部。

3 按中国药典附录44页取样方法取供试液。供试液置滤器中静置1min后,用脚踏吸引器缓缓抽气,使抽滤瓶逐渐形成负压,直到抽滤至滤膜近干。抽滤过程仅需30s左右,滤膜无损坏,效果很好。

(1990年12月13日收稿)